المسح الصحي للأسر في سهول النخيل 2021

مؤسسة الريحان للتنمية — برنامج الصحة المجتمعية ووحدة الرصد والتقييم

أيار/مايو 2021

> وثيقة مُصطنعة لأغراض العرض والاختبار؛ جميع الأسماء والأرقام والجهات الواردة فيها خيالية.

لماذا هذا المسح؟

بعد توقف العيادات المتنقلة عدة أشهر في العام الماضي، احتاج برنامج الصحة المجتمعية إلى صورة محدثة عن الوضع الصحي للأسر في محافظة سهول النخيل قبل التخطيط للتوسع. فالسجلات الروتينية للعيادات تخبرنا عمّن وصل إلينا، لكنها لا تخبرنا عمّن لم يصل.

لذلك نفذ البرنامج، بالتعاون مع وحدة الرصد والتقييم، مسحاً أسرياً بين 8 آذار/مارس و22 نيسان/أبريل 2021 في 12 تجمعاً سكانياً تخدمها العيادات المتنقلة الأربع. وركز المسح على أربعة محاور: صحة الطفل، وصحة الأم، والوصول إلى الخدمات الصحية، والإنفاق الصحي للأسرة.

أشرفت على المسح د. منى الشامي (اسم مستعار)، مديرة برنامج الصحة المجتمعية، ونفذه 20 باحثاً وباحثة، بينهم 14 من متطوعي الصحة المجتمعية بعد تدريبهم خمسة أيام على أداة المسح وأخلاقيات البحث.

المنهجية والعينة

اختيرت الأسر بطريقة العينة العنقودية، إذ قُسّم كل تجمع إلى مربعات سكنية سُحبت منها الأسر عشوائياً. وأُجريت المقابلات مع الأم أو مقدّمة الرعاية الرئيسية للأطفال في 88% من الأسر. واستُخدمت بطاقات التطعيم المنزلية مصدراً أول لبيانات اللقاحات، مع الاعتماد على إفادة الأم عند عدم توفر البطاقة.

المنطقة	عدد التجمعات	عدد الأسر
تجمعات الوادي الأعلى	4	520
تجمعات السهل الأوسط	5	610
التجمعات الحدودية	3	370
المجموع	**12**	**1,500**

بلغ متوسط حجم الأسرة 5.8 أفراد، وتضم 61% من الأسر طفلاً واحداً على الأقل دون الخامسة. وتعمل أغلب الأسر في الزراعة الموسمية، ويتراجع دخلها في أشهر الشتاء.

حصل الفريق على موافقة شفهية من كل أسرة قبل المقابلة، ولم تُسجَّل الأسماء في قاعدة البيانات، بل استُخدم رمز مثل FAKE-HH-0001 لكل أسرة.

صحة الطفل

المؤشر	النتيجة
الأطفال بعمر 12–23 شهراً الذين تلقوا جميع اللقاحات الأساسية	82%
الأطفال بعمر 6–59 شهراً المصابون بسوء تغذية حاد متوسط	6.5%
الأطفال بعمر 6–59 شهراً المصابون بسوء تغذية حاد شديد	1.2%
الأطفال دون الخامسة الذين أصيبوا بالإسهال خلال الأسبوعين الماضيين	14%
حالات الإسهال التي عولجت بمحلول الإرواء الفموي	58%

تُعد نسبة التغطية الكاملة باللقاحات جيدة نسبياً، لكنها تخفي تفاوتاً واضحاً بين المناطق، إذ تنخفض في التجمعات الحدودية إلى نحو ثلثي الأطفال فقط. وكان التأخر في الجرعات الأخيرة السبب الأكثر شيوعاً لعدم اكتمال التطعيم، خاصة لدى الأسر التي فاتها موعد العيادة المتنقلة خلال فترة التوقف.

وقيس سوء التغذية بشريط قياس محيط منتصف الذراع لـ 1,180 طفلاً، وأحيلت الحالات الشديدة فوراً إلى مركز التغذية العلاجية في مركز المحافظة.

صحة الأم والوصول إلى الخدمات

المؤشر	النتيجة
النساء اللواتي أجرين أربع زيارات رعاية أو أكثر خلال الحمل الأخير	57%
الولادات التي تمت في منشأة صحية	71%
الأسر التي تبعد أكثر من 5 كيلومترات عن أقرب مركز صحي	46%
الأسر التي تعرف موعد زيارة العيادة المتنقلة لتجمعها	63%
متوسط الإنفاق الشهري للأسرة على الصحة من مالها الخاص	34 دولاراً أمريكياً

يتضح أن المسافة ما زالت العائق الأكبر أمام الرعاية المنتظمة، إذ ذكرت 41% من الأسر كلفة المواصلات سبباً لتأجيل زيارة الطبيب. كما أن أكثر من ثلث الأسر لا يعرف متى تصل العيادة المتنقلة إلى تجمعه، ما يعني أن جزءاً من الطلب على الخدمة يضيع بسبب ضعف التواصل لا بسبب غياب الخدمة.

ويشكل الدواء الجزء الأكبر من الإنفاق الصحي للأسر، تليه أجور النقل إلى المراكز الصحية.

الاستنتاجات والتوصيات

يؤكد المسح أن العيادات المتنقلة تسد فجوة حقيقية في سهول النخيل، لكن عددها الحالي لا يكفي لتغطية التجمعات البعيدة بزيارة أسبوعية منتظمة. وبناءً على النتائج يوصي الفريق بما يلي:

- زيادة عدد العيادات المتنقلة من أربع إلى ست، وتخصيص إحدى العيادتين الجديدتين للتجمعات الحدودية.
- تدريب 30 متطوعاً ومتطوعة إضافيين في الصحة المجتمعية لمتابعة الحوامل والأطفال الذين فاتتهم جرعات اللقاح.
- إعلان جدول ثابت لزيارات العيادات المتنقلة، ونشره عبر المساجد والمدارس ورسائل نصية قصيرة إلى الأسر المسجلة.
- توفير الأدوية الأساسية مجاناً في العيادات المتنقلة لتخفيف الإنفاق الصحي على الأسر الأشد فقراً.
- تكرار المسح نفسه بعد عامين لقياس التغير في المؤشرات.

سيُعرض هذا التقرير على مجلس الإدارة والجهات المانحة المحتملة، ويمكن الاطلاع عليه مع أداة المسح عبر الرابط https://example.org/surveys/chp-household-2021.